桃園市政府衛生局　失智症教育訓練

# 看見改變，守住日常的安全

## 失智症健康問題辨識與安全照護

2026 年 11 月 4 日（三）13:00–16:35

桃園市工業會 1202 教室（桃園區縣府路 332 號 12 樓）

講師｜鍾孟修 職能治療師　主辦｜桃園市政府衛生局 醫事管理科

**掃描開啟互動講義**

mattsue1003.github.io/taoyuan-dementia-safe-care

# 鍾孟修 職能治療師



- 愛迪樂有限公司 執行長｜愛迪樂居家職能治療所 所長
- 社團法人台灣生活復能健康促進協會 副理事長
- 中華高齡專業照護訓練協會 理事
- 《讓你健康不失智》作者（商周出版，2025）
- Homeseen 失智症桌遊 共同創辦人
- 社區大學講師；ICOPE 評估員、照顧者與長照專業人員培訓講師

**加入粉絲專頁**

「鍾孟修 職能治療師」
新的免費教案與工具都會先在粉專分享

# 今天的路線：辨識 → 判斷 → 照護 → 資源

| 時間 | 單元 | 重點 |
| --- | --- | --- |
| 13:00–13:15 | 開場暖身 | 你身邊有沒有「怪怪的」長輩？ |
| 13:15–13:55 | 01 認識失智症 | 台灣現況、類型、病程、與正常老化的差別；風險因子與治療 |
| 13:55–14:35 | 02 早期辨識 | 十大警訊、AD8 實作、ICOPE / SPMSQ 比較 |
| 14:35–14:45 | 休息 | 伸展一下，喝口水 |
| 14:45–15:25 | 03 健康問題辨識 | 譫妄、精神行為症狀、疼痛、跌倒、營養與感染 |
| 15:25–16:05 | 04 安全照護 | 居家環境、防走失、用火用電、用藥、開車、防詐騙 |
| 16:05–16:25 | 05 溝通．復能．預防 | 情境演練、認知復能、健康促進、三高與痠痛 |
| 16:25–16:35 | 06 資源與測驗 | 求助管道、教案資源庫、Q&A |

# 破冰：台灣金曲猜歌




## 先唱一首長輩年輕時的歌，再開始上課

- 50 年代唱到 2026：15 組歌單共 300 首
- 國語、台語、鄧麗君、鳳飛飛特輯
- 聽前奏分組搶答；追問「這首歌讓你想起什麼？」
- 帶長輩時不比快，跟著哼就算答對

**掃描開啟台灣金曲猜歌**

mattsue1003.github.io/pop-song-guess

*01*

# 認識失智症

失智症不是單一疾病，而是一群症狀：記憶、語言、判斷、空間感等認知功能退化，嚴重到影響日常生活與人際互動。

# 你猜得到嗎？

*Q1* **目前台灣超過 100 歲的長者有幾位？**

A　約 6,500 位

B　約 1,200 位

2026 年全台百歲人瑞共 6,489 位，比前一年增加約 13%，首度突破 6 千人。

*Q2* **目前台灣有紀錄的最高齡長者是幾歲？**

A　109 歲

B　122 歲

衛福部 2025 年統計：最高齡為臺北市 122 歲女性長輩；男性最高齡 115 歲。

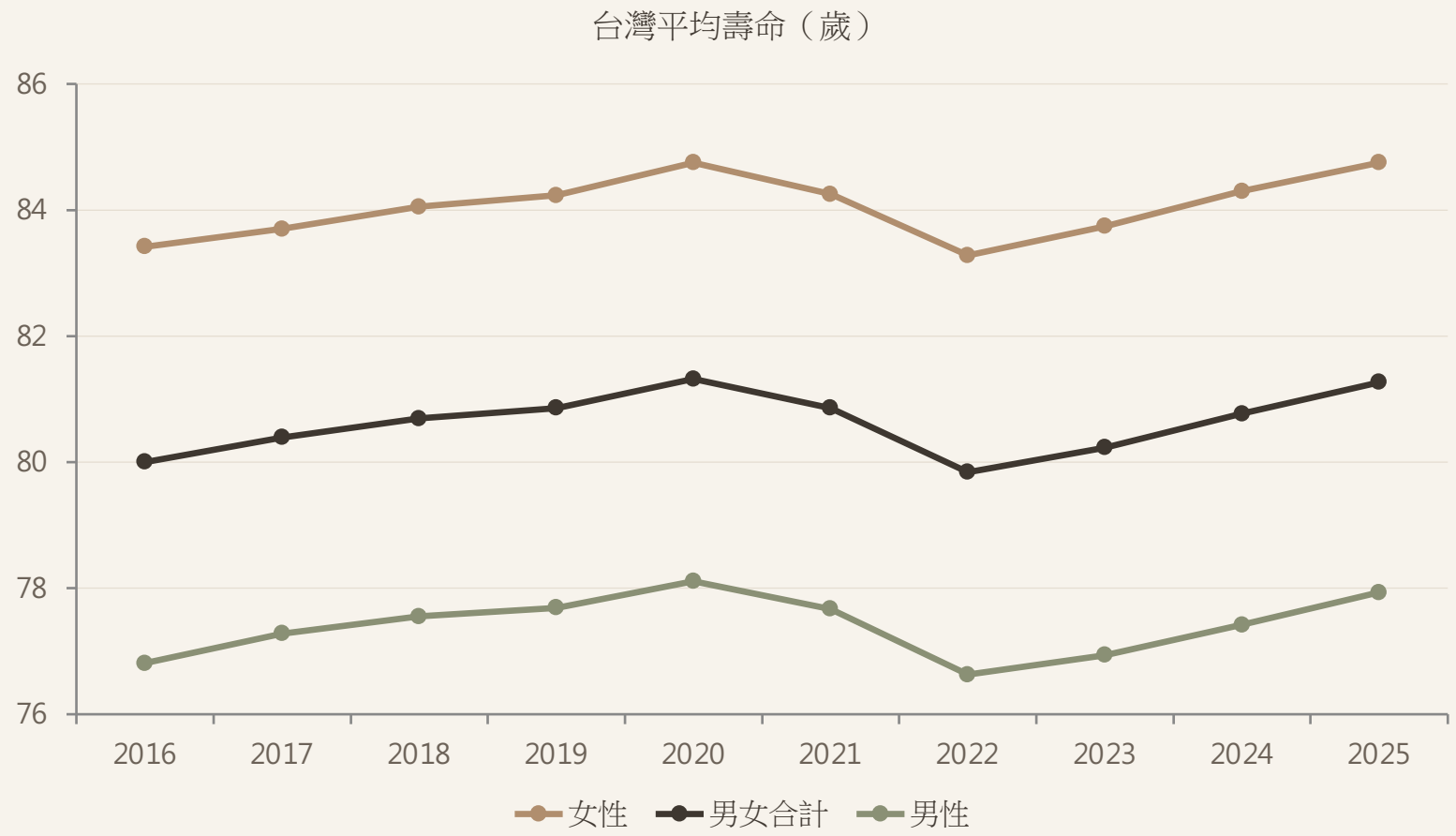
*Q3* **台灣目前的平均壽命是多少？**

A　76.5 歲

B　81.3 歲

2025 年平均壽命 81.27 歲：女性 84.75 歲、男性 77.93 歲。

# 活得更久，失智的人數也會增加




## 讀圖重點

- 十年來大致上升，2020 年達高峰 81.32 歲
- 2022 年受疫情影響降到 79.84 歲，之後連續三年回升
- 2025 年 81.27 歲
- 女性一直比男性多活約 7 歲
- 壽命越長，預防與照護越重要

資料來源：內政部 105–114 年簡易生命表。2016–2018 年數值請以內政部公告再次核對。

# 每 12～13 位長者，就有 1 位失智

*7.99%*

65 歲以上長者失智症盛行率

*17.53%*

65 歲以上輕度認知障礙（MCI）盛行率，是介入、延緩的黃金時期

*45%*

失智症風險可能與 14 項可改變的危險因子相關，預防是做得到的

資料來源：衛生福利部 2020–2023 全國失智症流行病學調查；The Lancet Commission on Dementia, 2024。

# 常見的四種類型

1

## 阿茲海默症

最常見。早期以「近期記憶」退化為主，病程緩慢持續進展。

2

## 血管型

中風或腦血管病變後出現，常呈階梯式退化，與三高控制密切相關。

3

## 路易氏體

認知功能時好時壞、常見鮮明視幻覺，合併類巴金森症狀，易跌倒。

4

## 額顳葉型

發病較早（常在 65 歲前），以個性、行為改變或語言障礙為主，記憶反而較晚受影響。

# 不同類型，怎麼互動與照顧？（一）

| 類型 | 最明顯的困難 | 互動怎麼做 | 照顧與安全重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| **阿茲海默症** | 近期記憶差、重複問話、找東西、迷路；舊記憶保留較久 | 重複問就平靜地再答一次；不要考他「記得我是誰嗎？」；多用老照片、老歌聊往事 | 外在記憶輔助（白板、大日曆、物品固定位置）；防走失；黃昏症候群時減少刺激、白天多曬太陽 |
| **血管型** | 反應變慢、注意力與計畫能力差，常合併中風後肢體、吞嚥問題；情緒起伏、憂鬱 | 說慢一點、一次只講一件事，多等他回應；給選擇題；情緒失控時先陪伴，不講道理 | 控制血壓、血糖、血脂，避免再中風；評估吞嚥與跌倒；中風後復健要持續 |
| **路易氏體** | 認知時好時壞、鮮明視幻覺、手抖動作慢、睡夢中拳打腳踢、姿勢性低血壓 | 看到幻覺不爭辯，先接納感受再轉移；重要的事挑他狀況好的時段做 | 照明均勻、減少陰影；跌倒風險很高；對抗精神病藥物非常敏感，就醫一定要告知診斷 |

# 不同類型，怎麼互動與照顧？（二）

| 類型 | 最明顯的困難 | 互動怎麼做 | 照顧與安全重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| **額顳葉型（行為型）** | 個性改變、衝動、沒禮貌、冷漠、重複固定行為、愛吃甜食；記憶反而還不錯 | 不要把行為當成故意；不講道理、不責備，改用轉移注意與固定作息 | 管理金錢、信用卡、開車與食物取得；發病年輕，照顧者壓力要特別關注 |
| **額顳葉型（語言型）** | 想不起字、說不出名稱，或聽不懂詞義；其他能力早期多保留 | 用圖卡、手勢、寫字、是非題；給時間找字，不搶話 | 及早做溝通板、常用句卡；請語言治療師評估 |
| **混合型** | 高齡長輩最常見：阿茲海默合併血管病變 | 依當下最明顯的症狀調整 | 記憶支持與三高控制並行 |

一句話記住　阿茲海默：補記憶　|　血管型：放慢、控三高　|　路易氏體：防跌、慎用藥、看好時段　|　額顳葉：管行為、不講道理

# 老了？還是病了？

| | 正常老化的健忘 | 失智症 |
|---|---|---|
| **忘記的範圍** | 忘記部分細節，例如人名 | 忘記整件事，例如剛吃過飯 |
| **提示後** | 經提醒會想起來 | 提醒了也想不起來 |
| **病識感** | 知道自己會忘，會用筆記補救 | 常否認忘記，或合理化 |
| **日常生活** | 不受影響 | 逐漸影響工作、理財、家務 |
| **病程** | 多年變化不大 | 持續且逐漸惡化 |

# 病程三階段：每個階段的重點在哪裡？

| 階段 | 常見表現 | 復能重點 | 居家照護重點 | 健康促進重點 |
|---|---|---|---|---|
| **輕度** | 近期記憶差、重複問話、理財與複雜家務出錯，外表看似正常 | 練策略、維持角色：記事本、手機鬧鐘、藥盒；繼續做家務、買菜，目標由長輩自己訂 | 固定作息與物品位置；簡化環境、標示抽屜；規劃意定監護、財務與醫療意願 | 最有機會延緩：有氧＋肌力運動、地中海飲食、社會參與、控三高、矯正聽力 |
| **中度** | 時間地點混淆、需協助穿衣如廁、遊走與妄想 | 靠環境與步驟化：拆解穿衣、洗澡、備餐，用提示階梯；保留做得到的部分 | 防走失；廚房浴室安全、夜燈；處理精神行為症狀；照顧者喘息服務 | 陪著一起動：散步、帶動跳、坐姿運動；據點或日照；顧營養、水分、睡眠 |
| **重度** | 語言大幅退化、行動與吞嚥困難、日常全依賴 | 參與與舒適：參與一部分（握湯匙、翻身時配合）；音樂、觸摸等感官刺激 | 預防壓傷、吸入性肺炎、脫水；擺位移位、口腔清潔；規劃安寧緩和 | 維持關節活動與坐姿耐力、每天下床曬太陽；照顧者自己的健康也要顧 |

輕度把力氣放在健康促進與策略學習；中度放在居家環境與安全；重度放在舒適、預防併發症與照顧者支持。目標從「獨立」慢慢轉成「參與」。

# 開場暖身影片




有趣好玩・4:41・掃描右下 QR Code 觀看

## 阿嬤的大腦迷宮

新北市衛生局動畫，走進失智者的大腦，看懂為什麼會忘東忘西、迷路。




有趣好玩・5:42・掃描右下 QR Code 觀看

## 失智咖啡廳：送錯咖啡我招待！

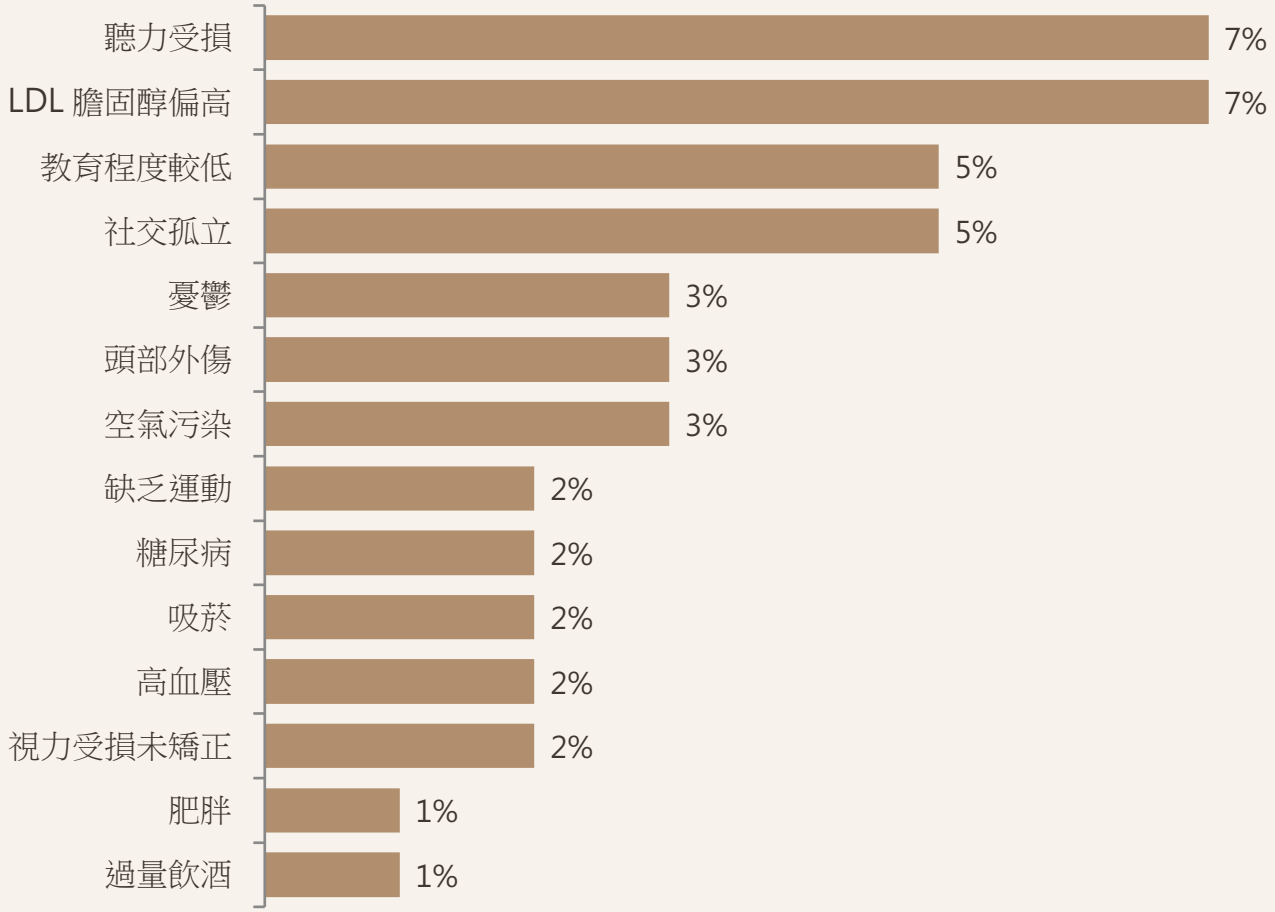
三立新聞。由失智長輩當店員，點錯、送錯都沒關係，討論「友善」是什麼。

*01+*

# 可預防的風險與治療

45% 的失智風險來自可以改變的因子；藥物能爭取的是「慢一點」。

# 14 項可改變的危險因子，各占多少？




14 項合計約 45%。Livingston G, et al. Lancet 2024;404:572–628。

## 每天可以做的事

- 聽力：定期檢查，需要時戴助聽器
- LDL：40 歲起驗血脂，必要時用藥
- 社交：參加據點、志工、興趣團體
- 運動：每週 150 分鐘 + 2 次肌力
- 血壓：中年起收縮壓 130 以下
- 戒菸；每週酒精少於約 168 公克
- 騎車戴安全帽，居家防跌
- 白內障及早治療，配合適眼鏡

# 什麼樣的個性，比較容易失智？

## 風險較高

- 神經質高：容易焦慮、緊張、情緒起伏大（最一致的發現）
- 負向情緒多：常生氣、悲傷、煩躁
- 盡責性低：較難維持運動、規律就醫
- 長期壓力與孤單感

## 風險較低

- 盡責性高：有條理、自律（保護效果最明顯）
- 開放性高：好奇、愛學新東西，累積認知存款
- 外向性高：社會參與多
- 正向情緒與人生目標感

這些是「相關」而非「注定」。2024 年整合 8 個世代、超過 4 萬人的研究：個性與「被診斷失智」有關，但和大腦病理關係不大，好個性可能讓大腦更能承受病變。培養興趣、維持人際、練習情緒調適，都是在幫大腦存款。

Terracciano A, et al. JAMA Psychiatry 2014；Aschwanden D, et al. 2021；Beck ED, et al. Alzheimer's & Dementia 2024。

# 台灣有藥可以治療失智症嗎？

目前沒有任何藥物可以治癒失智症，現有藥物的目標是「穩定症狀」或「延緩惡化」。

## 傳統藥物（健保）

- 愛憶欣、憶思能（有貼片）、利憶靈；中重度可用 memantine
- 改善神經傳導，讓功能暫時穩定
- 不會停止大腦病變
- 副作用：噁心、食慾差、腹瀉、心跳變慢

## 類澱粉單株抗體（自費）

- 樂意保 Leqembi、欣智樂 Kisunla，2025 年取得藥證
- 一療程約 18 個月，報導約 100–150 萬元以上
- 退化速度減緩約 27–35%，約多爭取 5–7 個月
- 限輕度、需確認類澱粉沉積；要定期 MRI 追蹤 ARIA

## 非藥物一樣重要

- 認知促進、懷舊、音樂
- 規律有氧與肌力、控制三高、改善聽力視力
- 據點、日照、家屬支持團體
- 精神行為症狀先用非藥物方法（DICE）

百萬元新藥能爭取的是「慢一點」，前提是很早期就診斷。van Dyck CH, et al. NEJM 2023；Sims JR, et al. JAMA 2023。費用以醫院公告為準。

# 低密度膽固醇（LDL），該怎麼看？

| 風險等級（健保 2026 新制） | 開始用藥 | 目標 |
|---|---|---|
| 極高風險（如急性冠心症） | ≥ 55 | < 55 |
| 非常高風險（已有心血管疾病） | ≥ 70 | < 70 |
| 高風險（如糖尿病） | ≥ 100 | < 100 |
| 中風險（2 項以上危險因子） | ≥ 115 | < 115 |
| 低風險（1 項危險因子） | ≥ 130 | < 130 |
| 無危險因子 | ≥ 160 | < 160 |

## 常見問題

- **130 還是 100？**130 是一般參考值，100 是理想值；現在都依個人風險決定目標
- **會遺傳嗎？**約一半與基因有關；家族性高膽固醇約每 250 人 1 人
- **吃魚油有用嗎？**魚油主要降三酸甘油酯，對 LDL 幾乎沒幫助
- **最有效？**Statin 降 30–50% 以上；生活型態約 10–20%
- **健保夠嗎？**多數人用健保 statin（必要時加 ezetimibe）就能達標；PCSK9 針劑留給極高風險

單位 mg/dL。健保署降膽固醇藥物給付規定；2025 台灣血脂管理臨床路徑共識。請勿自行停藥。

# 最新研究影片




最新研究・2:41・掃描右下 QR Code 觀看

## 刺胳針：14 項失智風險因子

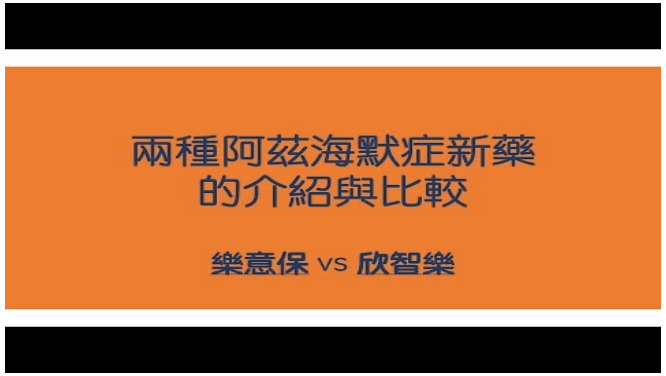
公視整理 2024 年報告重點。




最新研究・2:02・掃描右下 QR Code 觀看

## 失智新藥全台第一針

TVBS：延緩退化，不是逆轉記憶。




最新研究・9:09・掃描右下 QR Code 觀看

## 兩種新藥介紹與比較

邱銘章醫師說明適用對象與副作用。

*02*

# 早期辨識

十大警訊、AD8 極早期篩檢，以及 ICOPE、SPMSQ 的搭配與判讀。

# 失智症十大警訊

| | |
|---|---|
| 01 記憶減退，影響到生活 | 02 計劃事情或解決問題有困難 |
| 03 無法勝任原本熟悉的事務 | 04 對時間、地點感到混淆 |
| 05 理解視覺影像和空間關係有困難 | 06 言語表達或書寫出現困難 |
| 07 東西擺放錯亂，且失去回頭尋找的能力 | 08 判斷力變差或減弱 |
| 09 從職場或社交活動中退出 | 10 情緒和個性的改變 |

資料來源：台灣失智症協會。例：把錢包放進冰箱，找不到就懷疑被偷（警訊）vs 東西放錯會順著做過的事找到（正常老化）。

# AD8 極早期失智症篩檢：和「過去幾年」相比，是否有改變？

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 判斷力上的困難，例如落入圈套或騙局、財務上做出不好的決定 | 是 | 不是 | 不知道 |
| 2 | 對活動和嗜好的興趣降低 | 是 | 不是 | 不知道 |
| 3 | 重複相同的問題、故事和陳述 | 是 | 不是 | 不知道 |
| 4 | 學習使用工具、設備有困難，例如電視、遙控器、微波爐 | 是 | 不是 | 不知道 |
| 5 | 忘記正確的月份和年份 | 是 | 不是 | 不知道 |
| 6 | 處理複雜的財務有困難，例如收支平衡、繳費單 | 是 | 不是 | 不知道 |
| 7 | 記住約會的時間有困難 | 是 | 不是 | 不知道 |
| 8 | 有持續的思考和記憶方面的問題 | 是 | 不是 | 不知道 |

## 怎麼用

- 問的是「改變」，不是能力高低
- 勾「是」得 1 分
- 總分 ≥ 2 分，建議記憶門診、神經內科或精神科評估
- 篩檢不是診斷

AD8：Galvin et al., Neurology 2005；台灣中文版由台灣失智症協會推廣。由熟悉長輩的家屬或照顧者填寫最準確。

# AD8、ICOPE、SPMSQ 怎麼搭配？

| | AD8 | ICOPE 認知篩檢 | SPMSQ |
|---|---|---|---|
| **誰回答** | 熟悉長輩的家屬或照顧者 | 長輩本人當場作答 | 長輩本人當場作答 |
| **問什麼** | 8 題「和過去相比的改變」 | 記住三樣東西 + 今天日期與所在地點；同時篩行動、營養、視力、聽力、憂鬱 | 10 題定向、個人資料、時事與計算 |
| **判讀** | ≥ 2 分建議就醫評估 | 任何一項答錯，進一步評估或轉介 | 依錯題數分級；依教育程度調整 |
| **優點** | 對極早期變化敏感，不受教育影響 | 快速、全面，同時找出跌倒、衰弱等問題 | 簡單、不需工具，長照評估常用 |
| **常見陷阱** | 容易偽陰性：獨居、家人不常見面、「不知道」不計分、自填缺乏病識感 | 容易偽陰性：題目簡單，高教育或早期長輩容易通過 | 容易偽陽性：低教育、不識字、聽力差、緊張、憂鬱或譫妄時答錯 |

偽陰性 = 其實有問題卻顯示正常（錯過就醫時機）；偽陽性 = 其實沒失智卻顯示異常（家屬緊張、被貼標籤）。

# 判讀前先想一想

## 搭配建議

- 家屬觀察 + 本人表現一起看：AD8 搭配 ICOPE，任何一項異常就進一步評估
- 獨居或家屬不熟近況時，不要只靠 AD8
- ICOPE 通過但家屬很擔心，仍要相信家屬的觀察

## 先排除

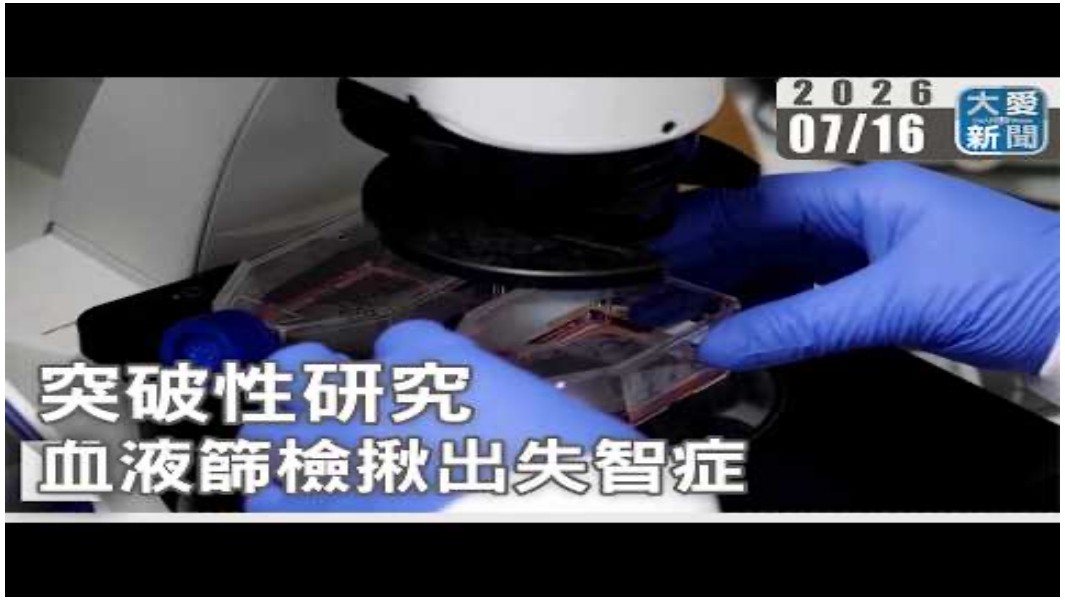
- SPMSQ 錯很多時，先問教育程度、看聽力視力、有沒有戴助聽器
- 最近有沒有生病、發燒、換藥、睡不好（譫妄）
- 情緒低落、焦慮也會讓分數變差

## 篩檢不是診斷

- 篩檢只決定「要不要轉介」
- 確診由醫師做完整評估：MMSE、MoCA、CDR、抽血與影像
- 半年到一年再篩一次，看「變化」比看一次分數重要

Galvin JE, et al. Neurology 2005；WHO ICOPE Handbook 2019；國民健康署 長者功能評估；Pfeiffer E. J Am Geriatr Soc 1975。

# 早期辨識的最新研究




最新研究・2:36・掃描右下 QR Code 觀看

## 抽血就能預測失智？

大愛新聞 2026：血液檢測可提早 5–10 年預測風險。




最新研究・4:22・掃描右下 QR Code 觀看

## 臺北榮總抽血驗早期阿茲海默症

TVBS：與韓國合作，準確率約九成。對照 AD8 談早期辨識。

*03*

# 健康問題辨識

失智長輩常說不清楚哪裡不舒服，身體的問題往往以「行為改變」的方式出現。

# 譫妄：最容易被誤認的急症

| | 譫妄 Delirium | 失智症 Dementia |
|---|---|---|
| **發生速度** | 急性，數小時到數天內 | 緩慢，數月到數年 |
| **一天之中** | 時好時壞，夜間常加重 | 相對穩定 |
| **注意力** | 明顯無法專注、答非所問 | 早期大致保留 |
| **意識** | 混亂、嗜睡或躁動 | 早期清楚 |
| **可逆性** | 找到原因並治療後多可改善 | 多為持續進展 |

長輩「突然」變得比平常更混亂、更嗜睡或更躁動，先想到譫妄，盡快就醫。常見誘因：泌尿道感染、肺炎、脫水、便秘或尿滯留、疼痛、新用藥、住院或搬家。

# 其他需要留意的健康問題

## 精神行為症狀 BPSD

- 妄想：覺得東西被偷
- 幻覺：看見不存在的人
- 遊走、反覆想「回家」
- 黃昏症候群：傍晚躁動
- 日夜顛倒、拒絕洗澡吃藥
- 憂鬱、淡漠

## 疼痛說不出口

- 皺眉、表情痛苦、呻吟
- 護著某個部位、不願移動
- 突然拒絕照顧、出手推人
- 食慾變差、睡不好
- 可用 PAINAD 量表觀察

## 跌倒、營養與感染

- 步態變慢、拖步
- 忘記喝水，脫水便秘
- 吃飯變慢、含著不吞、嗆咳
- 三個月內體重明顯下降
- 泌尿道感染常不發燒，只是「更混亂」

# 失智者最常出現的健康問題

| 問題 | 為什麼容易發生 | 照顧者可以觀察 |
|---|---|---|
| **跌倒與骨折** | 步態、判斷力、空間感退化，加上藥物 | 走路變慢拖步、常撞到東西、半夜起床如廁 |
| **吸入性肺炎** | 吞嚥協調變差 | 吃飯嗆咳、聲音濕濕的、反覆發燒 |
| **泌尿道感染** | 喝水少、憋尿、失禁 | 突然更混亂、尿味重、頻尿 |
| **營養不良與脫水** | 忘記吃喝、不會表達口渴 | 體重下降、皮膚乾、尿色深、便秘 |
| **便秘與失禁** | 活動少、喝水少、找不到廁所 | 腹脹、躁動、內褲弄髒、藏衣物 |
| **睡眠障礙** | 生理時鐘受損、日照不足 | 日夜顛倒、傍晚躁動、白天打瞌睡 |
| **多重用藥** | 多科就醫、忘記吃或重複吃 | 頭暈、嗜睡、跌倒、更混亂 |
| **口腔問題、憂鬱淡漠** | 忘記刷牙、假牙不合；缺少有意義活動 | 口臭、吃飯變少；整天坐著、不想參與 |

# 行為改變時，先找原因：DICE

*D*

### 描述 Describe

具體記下行為：什麼時候、在哪裡、和誰、前後發生什麼。

*I*

### 探究 Investigate

找原因：疼痛、便秘、感染、藥物、睡眠、環境太吵、照顧方式。

*C*

### 擬定 Create

團隊與家屬一起訂出非藥物做法：調整作息、簡化環境、安排活動。

*E*

### 評估 Evaluate

試行後追蹤，無效再調整，必要時才考慮藥物。

Kales HC, Gitlin LN, Lyketsos CG. BMJ 2015。

# BPSD：哪種方法最有效？

**高品質研究的共同結論：先找原因、非藥物優先；藥物是最後的安全網。**

| 方法 | 研究怎麼說 | 效果 |
|---|---|---|
| **先處理疼痛（找原因）** | 挪威 352 人隨機試驗：依步驟給止痛藥 8 週，躁動減少約 17% | 高 |
| **照顧者訓練 + 多元介入** | 23 個試驗統合分析：效果量 0.34，至少與藥物相當；家屬壓力也下降 | 高 |
| **多專業照護、按摩觸摸、音樂 + 觸摸** | 163 個試驗、2.3 萬人網絡統合分析：都比一般照護更能減少攻擊與躁動 | 中到高 |
| **量身活動、戶外與休閒** | 有效但幅度較小；依能力與興趣設計（TAP） | 中 |
| **環境調整** | 多為綜合方案的一部分；降噪、光線、可走動空間 | 中 |
| **抗精神病藥物** | 效果小，增加中風與死亡風險（約 1.6–1.7 倍）；只用在危及安全時，短期、低劑量 | 小，有風險 |

Watt JA, et al. Ann Intern Med 2019；Brodaty H, et al. Am J Psychiatry 2012；Husebo BS, et al. BMJ 2011；Gitlin LN, et al. 2008；Van Leeuwen E, et al. Cochrane 2018。

# 所以最好的方法是？

## 最好的方法

- 沒有單一最好；個別化、找原因、多元組合最有效
- 最常被忽略的原因是疼痛
- 照顧者學會方法，效果才會留在家裡

## 溝通上

- 接納情緒，不爭辯事實
- 轉移注意：換個地方、換件事做
- 給他一個角色與選擇，降低失控感

## 用藥上

- 路易氏體失智對抗精神病藥物特別敏感
- 每次回診問：「這個藥還需要嗎？」
- 躁動先排除藥物副作用

*04*

# 安全照護

安全不是把長輩關起來，而是調整環境，讓他在可控制的風險裡，繼續做自己能做的事。

# 居家安全檢核：勾不到的，就是回去要改善的

### 走道客廳

☐ 走道淨空，沒有電線、雜物、小地毯

☐ 感應夜燈照到廁所的路

☐ 常坐的椅子有扶手、好起身

☐ 家具角落加防撞護角

### 浴室

☐ 止滑墊或止滑處理

☐ 馬桶與淋浴區有扶手

☐ 有靠背的洗澡椅

☐ 熱水 50°C 以下

☐ 門鎖可從外面打開

### 廚房

☐ 自動熄火瓦斯爐或電磁爐

☐ 刀具、清潔劑收好

☐ 定期檢查過期食物

☐ 裝設住宅用火災警報器

### 臥室

☐ 床高適中，雙腳可平放

☐ 床邊有燈的開關

☐ 常用物品伸手可及

☐ 白天拉開窗簾

### 出入口

☐ 大門有感應鈴

☐ 愛的手鍊或指紋建檔

☐ 鑰匙、證件固定位置

☐ 門口留家屬電話

環境小訣竅：馬桶座、扶手、門框用與牆面不同的顏色；不希望長輩開的門，漆成與牆同色或掛布簾。

# 跌倒預防：延緩、訓練、復能

**47–90%** 失智者每年跌倒的比例，約為認知正常長者的 2 倍

**−32%** 職能治療師到家評估改善環境，高風險長者跌倒率降約三成

**−23%** 平衡與肌力運動，可降低社區長者約兩成跌倒率

## 延緩

- 請醫師、藥師檢視用藥
- 檢查視力聽力、穿防滑包覆鞋
- 補足水分與蛋白質
- 固定如廁時間

## 訓練

- 每週 3 次、累計 3 小時平衡與肌力
- 坐站練習、扶流理台側走
- 同一套、天天做、照顧者陪著做
- 太極、團體運動

## 復能

- 在真實情境練起身與轉位
- 夜燈、扶手、移除地毯
- 助行器、洗澡椅、離床感應墊
- 地上貼箭頭到廁所

World Guidelines for Falls Prevention, Age Ageing 2022；Cochrane 2023（環境）；Cochrane 2019（運動）。

# 延伸到社區：篩檢、分級、介入、環境、追蹤

*01*

**篩檢**

透過 ICOPE、據點與門診問三題：過去一年跌倒過嗎？走路會不穩嗎？擔心跌倒嗎？

*02*

**分級**

跌倒受傷、一年跌 2 次以上、衰弱或倒地爬不起來，屬高風險，轉介完整評估。

*03*

**介入**

據點規律平衡肌力課程；高風險者由職能、物理治療師居家評估與運動處方。

*04*

**環境**

人行道平整、照明充足、樓梯扶手、綠燈秒數足夠；申請居家無障礙改善補助。

*05*

**追蹤**

跌倒後 48 小時內回訪，找出原因，避免再發生。

# 防走失：事前、發生時、遇到時

## 事前準備

- 申請「愛的手鍊」
- 到警察局做指紋建檔
- 衣物、鞋子縫上聯絡資訊
- 保留近照與當日穿著紀錄
- GPS 定位裝置、門口感應鈴

## 發生時

- 立即撥 110，不必等 24 小時
- 先找常去、以前住過的地方
- 提供照片、穿著、手鍊編號
- 通知鄰里長、社區據點

## 遇到疑似走失長輩

- 從正面慢慢靠近，溫和打招呼
- 看看手腕有沒有愛的手鍊
- 陪在身邊，撥打 110
- 不要急著糾正他

# 定位裝置怎麼選？

| | 智慧定位鞋墊 | AirTag（放鞋內） | GPS 手錶 / 手環 | 愛的手鍊 |
|---|---|---|---|---|
| **定位原理** | 內建 GPS + 行動網路 | 沒有 GPS，靠附近 iPhone 回報 | GPS + 行動網路 | 不能定位，靠編號協尋 |
| **即時性** | 可即時、看軌跡 | 附近有 iPhone 才更新；鄉間深夜可能數小時無位置 | 可即時查看 | 需有人發現通報 |
| **電子圍籬** | 有，離開範圍推播 | 沒有真正的電子圍籬 | 多數有 | 無 |
| **被拿掉** | 藏鞋內，較不易察覺 | 要固定好 | 可能自行取下 | 不易取下 |
| **電力** | 定期充電 | 鈕扣電池約 1 年 | 經常充電 | 不需要 |
| **費用與補助** | 2026/7 起長照 3.0 智慧輔具租賃，3 年最高 6 萬元 | 約一千元，無月費、無補助 | 自費或部分縣市補助 | 社會局協助申請 |

怎麼選：AirTag 適合都市、輕度、偶爾外出的備援；易走失長輩優先選有 GPS 與電子圍籬的鞋墊或手錶，並搭配愛的手鍊與指紋建檔。

# 電子圍籬是什麼？

在地圖上畫一個看不見的範圍，例如以家為中心半徑 300 公尺，或家到市場、公園的路線。長輩一離開範圍，照顧者手機就收到通知。室內版：門口感應器、離床感應墊、出入口門鈴。

### 範圍

依習慣路線設定，GPS 有數十公尺誤差，不要太小

### 時段

依作息設定，傍晚到夜間加強

### 誰接手

事先決定誰收通知、誰去找、多久報 110

### 定期檢查

電量、鞋子有沒有換、App 通知

### 尊重

向長輩說明並取得同意，用最少限制保護安全

衛福部長照 3.0 智慧科技輔具租賃（ltcat.mohw.gov.tw）。產品功能與補助資格以官方資料庫與 1966 評估為準。

# 用火安全：輔具怎麼選？

| 輔具 | 做什麼 | 優點 | 限制與注意 |
|---|---|---|---|
| **瓦斯爐熄火安全裝置** | 火被湯溢或風吹熄時自動斷氣 | 新式瓦斯爐多已內建 | 忘記關火時不會自己關，防不了乾燒 |
| **定時熄火 / 防乾燒瓦斯爐** | 時間到或鍋底過熱自動關火 | 直接解決「忘記關火」 | 需換新爐；要會設定或家人預設 |
| **外掛瓦斯定時關閉器** | 裝在瓦斯開關，時間到自動關 | 不用換爐、價格較低 | 需專業安裝；長輩可能拆除或重開 |
| **瓦斯漏氣警報器 + 遮斷閥** | 偵測外洩就警報並關總開關 | 防外洩與一氧化碳 | 不偵測乾燒；要定期測試 |
| **電磁爐（IH 爐）** | 無明火，拿起鍋、過熱、定時會斷電 | 不點燃衣袖、無瓦斯外洩，整體較安全 | 要換鍋具；關掉後爐面仍燙；中度以上可能學不會 |
| **住宅用火災警報器** | 偵測煙霧或高溫並警報 | 依法每戶都應裝設 | 獨居者可選連動通知家人的款式 |

補助查證：長照輔具給付與 2026/7 智慧科技輔具首批 17 項都沒有自動熄火爐具或遮斷器，需自費；住警器可洽消防局，部分縣市對獨居長輩免費發放。

# IH 爐怎麼換、用電怎麼顧

## IH 爐怎麼換才順利

- 趁輕度就換，還學得會
- 只留一兩個按鍵，貼大字「開 / 關」
- 鍋具一起換，舊瓦斯爐移走
- 中度以上學不會時，改家人備餐或送餐

## 用電安全

- 電暖器選傾倒斷電、過熱保護
- 熱水瓶、電熨斗選自動斷電型
- 延長線有過載保護、不串接
- 智慧插座：手機遠端關閉、定時斷電
- 瓦斯熱水器加一氧化碳警報器

## 環境與習慣

- 廚房動作感應器：開火沒人在就通知
- 煮東西不離開廚房，用計時器
- 瓦斯總開關貼醒目標示
- 出門前一起檢查

# 用藥安全：藥盒怎麼選？有補助嗎？

## 基本原則

- 分格藥盒，照顧者每週備藥
- 固定同一家藥局
- 不自行增減或停藥
- 安眠鎮靜藥增加跌倒風險
- 藥品收好，只放當天的量

## 依程度選藥盒

- 輕度：大格分時藥盒 + 手機鬧鐘
- 輕中度：電子提醒藥盒，會響、亮燈、通知家人
- 中度以上：上鎖自動出藥機，一次只開一格
- 貼片藥寫上日期，撕舊再貼新

## 藥盒有補助嗎？

- 長照輔具、身障輔具與 2026/7 智慧輔具首批 17 項：都沒有藥盒品項，電子藥盒也沒有
- 縣市或計畫性發放各地不同，請洽 1966 或輔具資源中心
- 藥師居家訪視可協助整理藥物

# 開車：怎麼跟長輩談？

*01*

### 及早談、一起約定

確診時、輕度就談，約好「出現哪些狀況就停」

*02*

### 一起看警訊

熟悉路段迷路、變換車道困難、分不清油門煞車、車身多刮痕

*03*

### 請信任的人說

醫師、職能治療師駕駛評估，或長輩尊敬的親友

*04*

### 談安全，不談能力

先肯定他開了幾十年；說「擔心你被撞」而不是「你不行」

*05*

### 先安排替代交通

家人接送、長照交通接送、叫車 App、社區共乘

*06*

### 漸進減少

先停夜間、雨天、高速公路與遠路

*07*

### 最後手段

仍有危險才考慮保管鑰匙、移走車子，並和醫師討論

*08*

### 停開後顧心情

停止駕駛的長輩憂鬱焦慮較高，要安排社會參與

工具：台灣失智症協會與澳洲臥龍崗大學《失智症與安全駕駛決策輔助手冊》。75 歲以上每 3 年換照需體檢與認知測驗，但通過不代表可以安全開車。

# 預防詐騙：監護宣告、意定監護、信託怎麼選？

| 工具 | 適合誰 | 怎麼防詐 | 要知道的限制 |
|---|---|---|---|
| **安養信託** | 任何階段，越早越好 | 錢交給銀行管理，每月撥生活費；大額動用需信託監察人同意。簽約後馬上生效 | 有管理費；只保護放進信託的財產 |
| **意定監護** | 還清楚時，想自己決定將來誰照顧我 | 預先指定信任的人（可非親屬）並約定權限 | 需公證；簽了不會馬上生效，要等法院監護宣告後才啟動 |
| **輔助宣告** | 輕度、判斷力已下降 | 借錢、當保證人、買賣不動產等重要行為，要輔助人同意 | 需法院聲請約 3–6 個月；小額現金仍擋不住 |
| **監護宣告** | 中重度、無法判斷行為後果 | 由監護人代為處理，長輩自己簽的契約無效 | 失去法律自主、不能立遺囑；處分不動產須法院許可 |

清楚時：意定監護 + 安養信託一起做 → 輕度：再加輔助宣告 → 中重度：聲請監護宣告，由意定監護人接手。醫師確診不等於法院宣告，所以要提早規劃。

民法第 14、15-1、15-2、1113-2 條。實際規劃請諮詢律師、公證人或銀行信託部。

# 日常防護，和長輩怎麼說

## 日常防護

- 設定提款與轉帳限額，關閉不需要的網路銀行
- 帳戶異動簡訊同時通知家人
- 向聯徵中心申請註記，防冒名開戶、貸款
- 地政事務所「地籍異動即時通」
- 開啟陌生來電過濾，家中貼上 165 反詐騙專線

## 和長輩怎麼說

- 說「保護你的錢不被騙」，不說「你不會管錢」
- 留一點零用錢讓他自己支配，保有尊嚴
- 和常去的銀行、里長、店家打招呼，請他們多留意

*05*

# 溝通・復能・預防

好的照護，是讓長輩在被理解的關係裡，盡可能自己完成生活中的事。

# 溝通時這樣做、盡量避免

## 這樣做

- 從正面靠近，蹲下平視
- 先叫名字，等他看你再開口
- 句子短、一次說一件事
- 給時間回答，不催促
- 用動作、物品、圖卡輔助

## 盡量避免

- 爭辯對錯、考他「我是誰？」
- 當面和別人討論他的病情
- 用對小孩說話的語氣
- 一次問很多問題
- 從背後突然碰觸




有趣好玩・5:04

**邀阿公阿嬤拍 B 級殭屍片**

有角色、有參與，就是最好的復能。

# 失智復能是什麼？研究怎麼說？

**復能不是「把認知練回來」，而是讓長輩在自己家裡、自己在意的生活中，用環境、輔具與策略，重新做得到。**

| 方法 | 研究結果 |
| --- | --- |
| **認知訓練（反覆練題目）** | Cochrane 2019：測驗分數可能小幅進步，證據品質低；很少轉移到日常生活 |
| **認知刺激治療（CST）** | Cochrane 2023：認知、溝通與生活品質小到中度改善 |
| **目標導向認知復健** | GREAT 試驗 475 人：目標達成度明顯提升，持續 9 個月；一般認知分數不變 |
| **環境與照顧者策略** | COPE、TAP 試驗：功能依賴降低、參與提升、行為症狀減少，照顧者負擔下降 |
| **社區復能方案** | 可改善 ADL、IADL 與生活品質，早期失智、MCI 效果較好 |

結論：單純認知訓練對日常生活幫助有限；讓長輩「做得到」的，是以生活目標為核心，搭配友善環境、輔具與照顧策略。

Metzelthin SF, et al. Ageing & Society 2022（復能定義）；Bahar-Fuchs 2019；Woods 2023；Clare 2019；Gitlin 2008、2010。

# 做認知復能要注意什麼？

1 **先排除可逆因素**

譫妄、憂鬱、疼痛、便秘、藥物、聽力視力、睡眠

2 **目標由長輩訂**

問他最想自己做到什麼；看生活目標，不看分數

3 **在真實情境練**

要煮早餐就在自家廚房練，固定時間流程

4 **不考試、不讓他失敗**

用無錯誤學習，先給足提示再慢慢減少

5 **依類型與病程調整**

路易氏體挑好時段；額顳葉型多用固定流程

6 **短時段、結束在成功**

每次 10–20 分鐘，皺眉坐不住就退一步

7 **照顧者一起學**

全家用同一套提示與說法

8 **安全與尊嚴並重**

有人陪伴下讓他嘗試，不全部代勞

9 **定期重新評估**

從「自己做」調整為「參與一部分」

# 復能：從最少的協助開始

照顧者「做得快」，長輩就失去練習的機會。把目標放在他在意的事：自己吃飯、去市場、照顧盆栽，每天的生活就是訓練。

協助程度 →

### 先等待

給 5–10 秒，看能不能自己開始

### 口語提示

「我們先把右手放進袖子裡」

### 手勢指引

指著衣袖、輕拍要用的手

### 示範動作

自己做一次給他看

### 部分協助

手放在他的手上引導開頭

### 完全協助

前面都試過，才由照顧者代勞

# 自立支援「三不四要」× 失智復能

| 不 | 不 | 不 | 要 | 要 | 要 | 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **不約束** | **不包尿布** | **不臥床** | **要喝水** | **要營養** | **要排便** | **要運動** |
| 改用陪伴、感應器 | 定時引導如廁 | 白天起身、出房門 | 約 1500 cc，依病況調整 | 約 1500 大卡、足夠蛋白質 | 規律、自然排便 | 每天 15–30 分鐘 |

| | 自立支援「三不四要」 | 失智復能 |
|---|---|---|
| **出發點** | 源自日本，從身體基本需求切入 | 以人為中心，從「長輩想做什麼」訂目標 |
| **強項** | 規則簡單、人人能做；改變「幫他做」的文化 | 個別化；環境、輔具、提示策略、跨專業 |
| **對失智的幫助** | 脫水、便秘、營養不良是譫妄與躁動的常見原因 | 記憶判斷退化時，用環境與策略讓他做得到 |
| **要注意** | 國際試驗較少；1500 cc 不適合心衰竭、腎病 | 需要評估與時間；照顧者要一起執行 |

# 取長補短：怎麼一起用？

## 四要當地基

- 先顧好水分、營養、排便、活動，再談訓練
- 行為突然變差，先檢查四要
- 用他喜歡的杯子、固定時間一起喝

## 三不用失智的方法做

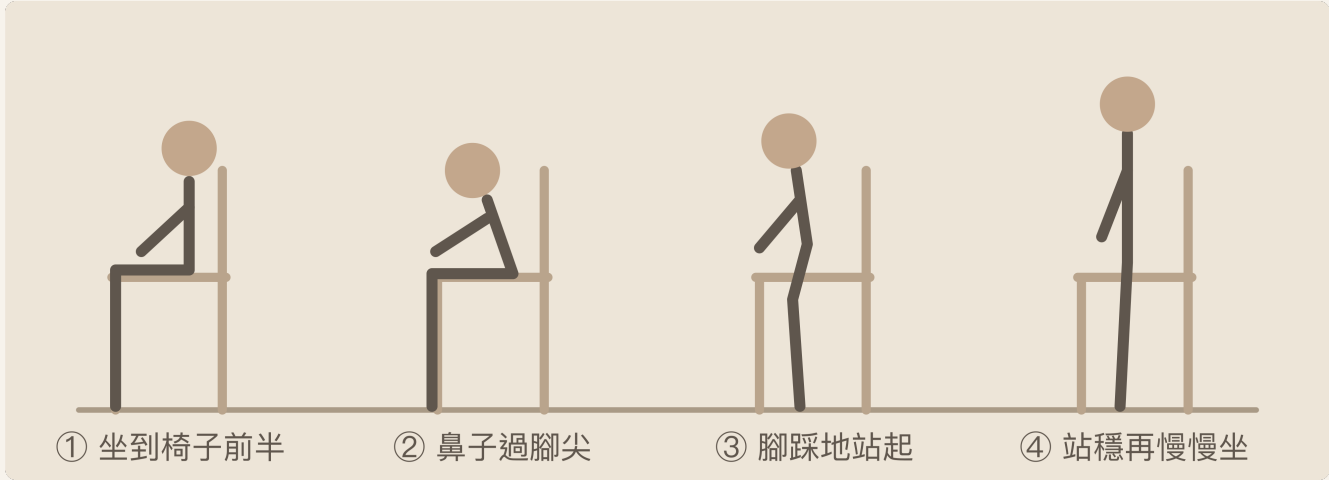
- 不包尿布：看出如廁訊號、定時引導、門貼圖卡
- 不約束：離床感應墊、低床、陪伴
- 不臥床：白天排有角色的活動

## 復能補上目標與策略

- 用他在意的事當動機
- 步驟拆解、提示階梯、無錯誤學習
- 環境與輔具讓他自己完成

三不四要讓身體「有本錢」，復能讓長輩「有目標、有方法」。兩者合在一起，才是失智長輩的自立支援。

# 坐站練習（Sit to Stand）：每天最值得做的一個動作




**能從椅子站起來，就能自己上廁所、自己下床、自己出門。**

坐站一天要做幾十次，同時練大腿肌力、平衡與轉位；不用器材、不用學新東西，放進每天的照顧流程就好。

## 放進日常

- 上廁所、吃飯前、看電視廣告時起立 5 次
- 一天 3–4 回，邊數數或唱歌

## 口訣與提示

- 屁股往前、腳往後、鼻子過腳尖、站起來
- 扶手 → 不扶 → 手抱胸 → 慢慢坐

## 安全

- 椅子穩固有扶手；站起先停 3 秒
- 痛、喘、頭暈就休息，有人在旁

# 坐站練習的研究證據

| 研究 | 對象與做法 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| **加拿大 MOVE（2015）** | 7 家護理之家、111 位失智住民；照服員每天在照顧中提醒坐站 | 6 個月坐站能力維持住，日常功能退化比對照組慢 |
| **德國隨機試驗（2017）** | 97 位輕中度失智者學習代償式坐站技巧 10 週 | 學得會、記得住，3 個月後仍保留 |
| **系統性回顧（2018）** | 43 個試驗、MCI 與失智者的監督式運動 | 30 秒坐站多 2 次；步速、平衡、起身行走都進步 |
| **巴西居家試驗（2021）** | 40 位輕中度阿茲海默症，16 週居家運動 | 五次坐站變快、跌倒風險下降 |
| **澳洲 Sunbeam（2022）** | 護理之家認知障礙住民，漸進肌力 + 平衡 | 跌倒率減少 50%，坐站與平衡較好 |
| **瑞典護理之家（2020）** | 每天 4 次坐站 + 營養補充 12 週 | 整體未達顯著；規律做到的人維持或進步機會高 3.5 倍 |

Slaughter SE, et al. JAMDA 2015；Werner C, et al. J Alzheimers Dis 2017；Lam FMH, et al. J Physiother 2018；Cezar NOC, et al. 2021；Mak A, et al. JAMDA 2022；Grönstedt H, et al. JAMDA 2020。

# 健康促進：比預防疾病更積極

| | 疾病管理 | 健康促進 |
|---|---|---|
| **對象** | 已確診疾病的人 | 所有人，不論有沒有病 |
| **目標** | 控制病情、減少併發症 | 提升身心功能、生活品質與參與 |
| **主導** | 醫療團隊 | 個人、家庭、社區與政策一起 |
| **指標** | 血壓、血糖、再住院率 | 內在能力、活動參與、幸福感 |
| **例子** | 糖尿病衛教、按時服藥 | 社區運動班、友善步道、長輩當志工 |

## 只有走路夠嗎？

- WHO 2020 建議長者：有氧每週 150–300 分鐘
- 肌力每週至少 2 天，要漸進負荷
- 平衡與多元運動每週至少 3 天
- 加入速度、阻力、平衡與雙重任務
- 認知：多面向、有挑戰的新學習（FINGER、US POINTER）

WHO Ottawa Charter 1986；WHO Physical Activity Guidelines 2020；Ngandu T, et al. Lancet 2015；Baker LD, et al. JAMA 2025。

# 心臟血管：99% 早就有警訊




- 2025 年《美國心臟病學會期刊》追蹤 930 萬人：**心肌梗塞、心衰竭、中風前，99% 以上早有至少一項警訊**
- 四個警訊：血壓、膽固醇、血糖、吸菸；超過九成不只一項
- 「正常」不等於「理想」：沒到診斷標準不代表沒事
- 這四個警訊也是失智危險因子：**顧心臟，就是顧大腦**

Lee H, et al. J Am Coll Cardiol 2025。

# 四個警訊自我檢查・健康八要素




## 健康八要素（美國心臟協會）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ 血壓<br>120/80 以下 | ☐ 血脂<br>膽固醇控制好 | ☐ 血糖<br>空腹 100 以下 | ☐ 不吸菸<br>也避開二手菸 |
| ☐ 健康飲食<br>蔬果全穀少加工 | ☐ 規律活動<br>每週 150 分鐘 | ☐ 健康體重<br>合適 BMI | ☐ 睡眠充足<br>每晚 7–9 小時 |

**健康八要素完整做法**

mattsue1003.github.io/health-education-8

挑一項還沒做到的，拆成每天的小步驟

# 失智長輩的三高怎麼管？

| | 失智後的目標 | 失智帶來的困難 | 照顧怎麼做 |
|---|---|---|---|
| **血壓** | 輕度、健康：多為 130/80 以下。衰弱或中重度：避免太低，不頭暈、不跌倒 | 忘記吃或重複吃；說不出頭暈；姿勢性低血壓 | 家屬量「722」家庭血壓；起身前先坐 30 秒；吃少變瘦時請醫師檢視降壓藥 |
| **血糖** | 健康長者糖化血色素約 7.0–7.5%；中重度或衰弱可放寬到 8.0% 以下，避免低血糖優先 | 認不出低血糖；飯量不穩；忘記打針或重複打 | 冒汗、躁動、突然更混亂先測血糖；飯量少時與醫師調藥 |
| **血脂** | 依心血管風險由醫師決定；末期以舒適為主，可討論停藥 | 藥物太多、吞嚥困難 | 他汀類藥物研究不支持會造成失智；整合成一天一次 |

三高控制好可降低失智風險、減緩血管型惡化；但已失智的長輩，最大危險常是「控制過頭」。輕度積極控制 → 中度控制與安全並重 → 重度以舒適為主。

SPRINT MIND, JAMA 2019；Lancet 2024；ADA Standards of Care: Older Adults 2025；台灣高血壓學會 2022（722：連續 7 天、早晚、各量 2 次）。

# 痠痛：為什麼 45–64 歲是疼痛高峰？




## 錯誤習慣的惡性循環

1. **久坐 + 低頭看螢幕**
   每天長時間累積
2. **肌肉一邊緊繃、一邊無力**
   上交叉、下交叉症候群
3. **關節活動度下降**
   組織缺氧，修復跟不上消耗
4. **出現疼痛，更不敢動**
   肌力再下滑，回到第一步

照顧者多在這個年紀，常一邊照顧長輩、一邊腰痠背痛。

# 影響最大的因子、最有效的運動

## 五個關鍵因子

- 久坐時間：6 小時以上風險最高
- 低頭滑手機：風險比用電腦高
- 肥胖、代謝症候群
- 睡不好、壓力大
- 缺乏規律運動

## 哪種運動最有效？

- 最推薦：肌力訓練、有氧 + 肌力複合
- 重要：有氧，規律累積、可分次
- 配角：伸展，改善緊繃
- 短期輔助：按摩，不能取代主動運動

## 給照顧者與長輩

- 移位用對姿勢與輔具
- 每坐 30–60 分鐘起來動
- 帶長輩一起做坐姿肌力

痠痛問題影片學習資料庫
46 種問題 × 專業示範影片

BMC Public Health 2025；JOSPT 2022、2023；Frontiers 2025；2018 美國身體活動指南。疼痛持續或加劇，請找醫師或物理治療師。

# 健康促進：趨吉避凶（國民健康署）

## 趨吉

- 多運動：每週至少 150 分鐘中等強度
- 多動腦：學新事物、閱讀、下棋、學才藝
- 多社會互動：據點、志工、聚會
- 均衡飲食：多蔬果、全穀、魚類

## 避凶

- 控制三高：血壓、血糖、血脂
- 避免頭部外傷，戴安全帽、預防跌倒
- 不吸菸、不過量飲酒
- 遠離憂鬱，聽力視力及早矯正

# 健康促進影片




有趣好玩・1:37・掃描右下 QR Code 觀看

**「我的餐盤」口訣歌帶動跳**

國健署長者版，全班一起跳。




最新研究・2:15・掃描右下 QR Code 觀看

**編織降低失智風險**

公視 2026 年 10 月報導。

06

# 資源與課後測驗

求助管道、教案資源庫、六題小測驗。

# 求助管道

**長照服務專線**

## 1966

長照評估、居家服務、喘息、輔具與無障礙補助

**失智症關懷專線**

## 0800-474-580

台灣失智症協會：照顧諮詢、情緒支持、資源轉介

**失智共照中心與據點**

## 國民健康署

協助確診與個案管理；據點提供認知促進、家屬支持

**愛的手鍊**

## 老人福利推動聯盟

防走失手鍊，可洽社會局或長照管理中心

**走失報案：110（不需等 24 小時）　|　桃園市政府衛生局 醫事管理科：03-3340935**

# 免費教案資源庫（1/2）：掃描即可開啟




失智照護

失智長輩活動資料庫



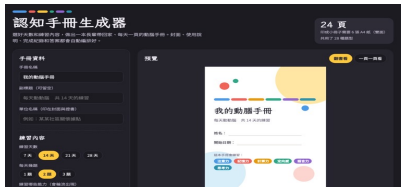

失智照護

失智症溝通技巧資料庫




失智照護

失智友善標示・提示卡生成器




失智照護

認知手冊生成器




失智照護

預防失智症｜從理解到行動




健康與痠痛

痠痛問題影片學習資料庫




健康與痠痛

按摩球影音資料庫




健康與痠痛

運動能止痛嗎？




懷舊與認知

老時代・懷舊活動資料庫




懷舊與認知

長者懷舊童玩資料庫

# 免費教案資源庫（2/2）：掃描即可開啟




懷舊與認知

**老寶貝話匣子**




懷舊與認知

**台灣重要事件互動圖卡**




音樂

**長者回憶高峰金曲 200**



音樂

**老歌律動影片資料庫**




音樂

**金曲猜歌 20 題**



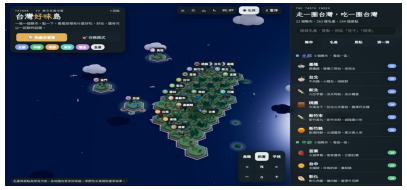

圖像

**看照片猜藝人**




圖像

**老藝人懷舊猜猜看**




台灣好味道

**台灣好味島**




台灣好味道

**台灣美食地圖・縣市小吃探險**

# 六題小測驗：○ 還是 ×？

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 失智症是正常老化的一部分，年紀大了都會發生。 | ○ | × |
| 2 | 長輩一兩天內突然混亂、時好時壞，應優先懷疑譫妄並就醫。 | ○ | × |
| 3 | 失智長輩走失，要等滿 24 小時才能報案。 | ○ | × |
| 4 | AD8 得分 2 分以上，建議進一步就醫評估。 | ○ | × |
| 5 | 照顧時能代勞就代勞，長輩才不會有挫折感。 | ○ | × |
| 6 | 約有四成五的失智症風險，與可以改變的生活因素有關。 | ○ | × |

*Thank You*

# 謝謝大家，
# 一起守護長輩的日常

加入粉絲專頁

收藏互動講義

講師 | 鍾孟修 職能治療師
愛迪樂有限公司 執行長、《讓你健康不失智》作者
課後有任何照護或活動上的問題，歡迎到粉絲專頁留言交流。

本講義整理自衛生福利部、國民健康署、台灣失智症協會公開資料與相關文獻，僅供教育訓練使用，個別健康狀況請諮詢專業醫療人員。影片版權屬各原發布單位所有。